جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : رحاب عبدالقادر محمود السبع
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الشيخ زايد **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 27610130101601 **رقم التليفون :** 01003320008 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 13-10-1976 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: رحاب عبدالقادر محمود السيع
National ID: 27610130101601

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





DMS
نومبر

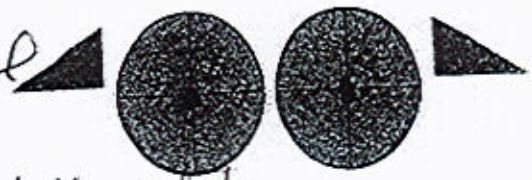
عاجل

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبـــادرة نحتفم صحة المرأة
مصر
01003320008

MDT FORM

Name	[illegible] عبدالقادر محمود
Age	45 years
MRN	٤٨٥٨ / C.C1.
ID	
Co morbidity	- on Eltroxin



Total thyroidectomy on FH.

Clinical Data

Bx: IDC grade II	SM: lt br. 2 masses at 2 o'clock 37x25mm & 12 o'clock → 16x9 mm
IHC: ER: 6/8 PR: 8/8 Her2: score 0 Ki67: 12%	Mets Workup: Pelvi-abd. uls → Free. Bone scan → Free - ~~Chest x-ray → Free~~
$pT_2 N_2 M_{9/15}$	

COMMENT:
Post. lt Quadrantectomy & Free surgical margins + ALND 9/15 L.Ns. (mass 3.2x2cm)
since 1month.
- Bilat Breast us
- CT CAP.
- ECHO.

MDT OUTCOME & PLAN

- f/Rec
For Adjuvat chemotherapy
AC x4 → Taxl 1/12wk. ⇒ Arm zolac + PORT
~~CISM after 6 month~~
For follow up

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
	Sarah		

18/11/2021

C.C1 / 11 / 18

Name: رحاب عبد القادر محمود السبع **MR. :** 6790	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient underwent an upfront left breast-conserving surgery (BCS) with axillary lymph node dissection (ALND) in October 2021, pathology reported T2 N0 (9/25 nodes negative). Adjuvant therapy was initiated with AC (doxorubicin and cyclophosphamide), followed by TAXWOL (paclitaxel), PORTH (radiation therapy), AI (aromatase inhibitor), and ZOLADEX (goserelin). In February 2025 the surgical margins were documented as free, and in January 2026 the patient was placed on ZOLADEX plus FEMARA (letrozole).

The patient presented today to receive FEMARA and ZOLADEX as prescribed, with the plan to continue ZOMETA after review of recent laboratory results.

Bilateral breast imaging demonstrated BIRADS 2 findings consistent with fibrocystic changes; the patient will continue Zoladex therapy as indicated.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:

Patient Name: *Rehab Abdullkader*	***Date of birth:*** *13/10/1976*
Arabic Name: رحاب عبدالقادر	***Patient Gender:*** *F*
Patient RIS ID: *340792* ***Patient HIS ID:*** *123022908*	***Exam Date:*** *26/10/2023*
Written by: Dr. Hoda Fathy	**Approved by:** Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (26/10/2023)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP

Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton however X-ray of the sternum is recommended.

Much Obliged

Omnia Talaat, MD

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

رهاب عبد القادر

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Rehab Abdel Kader Mahmoud Al Sabaa	Date : 10/12/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 4858/2021	Pat. ID: 14437

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

Scattered fibro glandular density (ACR B)

No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.

Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.

Complementary ultrasound showed left breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.

Right breast simple cyst measures 8 x 6 mm.

no right breast solid mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.

Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.

Left supra clavicular tiny lymph node measures 7 x 4 mm.

Opinion:

Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)

Right benign findings.

(BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Wafaa Ali

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : رحاب عبد القادر محمود السبع
Analysis ID : [redacted] 588102
Age : 45 Y
Gender : Female
Referred By Prof. Dr. : حسن الصوينى
Clinical Diagnosis : Left breast UOQ highly suspicious solid mass
Nature of Specimen : Block (US guided core biopsy)
Receiving Date : 2021-09-26
Patient ID : 459460

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Technique :

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain .
The sections were treated against:
Estrogen receptors
Progesterone receptors.
Her 2
Ki67

Results :

Sections treated for Estrogen receptors revealed POSITIVE Nuclear staining by chromogen.
Sections treated for Progesterone receptors revealed POSITIVE Nuclear staining by chromogen.
Sections treated for HER2 revealed NEGATIVE CELL MEMBRANE STAINING.
12% of Tumour cells are POSITIVE for Ki67.

Conclusion :

Block, TUMOUR CELLS ARE:
POSITIVE FOR ESTROGEN RECEPTORS (SCORE 6/ 8).
POSITIVE FOR PROGESTERONE RECEPTORS (SCORE 8/ 8).
NEGATIVE FOR HER 2 PROTEIN OVEREXPRESSION, SCORE 0.
THE PROLIFERATION INDEX OF KI67 IS 12 % OF TUMOUR CELLS.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void.

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT

الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

تاريخ الاصدار :2023-3-19 جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع لخضعين لقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والادامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنه 2042 " الاطفال دون السن العشرس" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي

والبحث تبين أن

السيد (ة) رحاب عبدالقادر محمود بطاقة رقم 27610130101601

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية بفرد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحي صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه :2023-3-19

افادة مركز نظم المعلومات
بحته....

مسلسل 556575

الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا في حالة تغير حالته الحوظي من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و وزارة التضامن الاجتماعي او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]